

INDICADO POR: Dr. Pedro.

☒ ACOMPANHAMENTO () CONSULTA

NS

JARBAS MATOS DA SILVA

IDADE: 68 PESO: 56 ALTURA: 1,50 PROFISSÃO: Aposentado / Vendedor.

SINTOMAS: Tem 2 episódios "Ausência" de esquecimento 1º há 4 anos
tem sonolência; Acorda com sono 2º há 3 meses

QUEIXAS: Deficit memória, Sono fragmentado; Despert; Demora pegar sono

MEDICAMENTOS: Pristata, Roxurasetina, Pantoprazol.

Conexão de 1

MÉDICO: Dr. Pedro Macedo - Neuro / Dr. Carlos Wellman.

MARCAPASSO: () S ☒ N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S () N

EXERCÍCIO FÍSICO: Academia 2x semana pilates

HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: ALMOÇO: LANCHE: JANTAR:

HORA QUE DORME: 23h HORA QUE ACORDA: 6h

COCHILHO: ☒ S () N DORME ACOMPANHADO: ☒ S () N () EVENTUALMENTETEM FILHOS: ☒ S () N / DORMEM NO QUARTO: () S ☒ N PET NO QUARTO: () S ☒ NBEBIDA ALCOÓLICA: () S () X NA SEMANA ☒ N esporádico Neta.

FUMO: () S () MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO: 80 na adolescência.

TIPO DE RESPIRAÇÃO: BANHEIRO/NOITE: 2 à 3x noite

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: MALLAMPATI: IA1: 59 SPO2: 78% ✓

PATOLOGIAS ASSOCIADAS: distúrbio hip: 743 $\downarrow$ N2: 71,9% $\downarrow$ N3: 3%.CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA $\uparrow$ Índia despertares - 20

HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:

COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA () ENDÓCRINA (S) CARDÍACA Urologista (X)

() ORTOPÉDICA (S) NEUROLÓGICA () OUTROS: nefrologista (X)

POLISSONOGRAMA COM CPAP: () S () N SPO2 C/ CPAP: PRESSÃO NO EXAME:

22/07/25 Ausência. Auto 4º 40cmH2O. max N30;

31/07/25 P= 5.1 auto (mediana)
IA4=44% Relata dificuldade de
21 de 20: 2h 25i dormir.
fusão: 31,8% (percentil)
Natachon

POLISSONOGRAFIA DE NOITE INTEIRA BASAL

Nome: JARBAS MATOS DA SILVA

Sexo: Feminino

Data do Exame: 03-06-2025

Idade: 68 anos

Peso: 56 kg

Altura: 1,52 m

Médico Solicitante: DR. PEDRO HENRIQUE DE ABREU
MACEDO

RELATÓRIO

O exame foi iniciado às 03/06/2025 21:42 e finalizado às 04/06/2025 05:45.

A latência para início do sono foi de 27,5 min e a latência para o sono REM de 105,0 min.

O tempo total de sono (TTS) foi de 308,0 min, com eficiência do sono de 63,7 %.

A distribuição dos estágios do sono mostrou 1,3 % de estágio N1, 71,9 % de estágio N2, 3,1 % de estágio N3 e 23,7 % de sono REM. O tempo acordado após o adormecer foi de 148,3 min. Ocorreram 164 despertares, sendo o índice de 20,3 (nº/h).

O índice de movimento periódico de membros inferiores foi de 0,0 (nº/h), 0 associado a despertares.

O número total de eventos respiratórios foi de 133, sendo 0 apneias obstrutivas, 0 apneias centrais, 0 apneias mistas, 133 hipopneias e 0 "RERAs". O índice de distúrbio respiratório (IDR) foi de 25,9 (nº/h). O IDR durante o sono REM foi de 43,6 e o IDR durante o sono NREM foi de 20,4. O índice de apneia/hipopneia (IAH) foi de 25,9 (nº/h), sendo 0,0 apneia/h e 25,9 hipopneia/h.

A saturação da oxi-hemoglobina (SAO₂) basal foi 92%, a média de 92% e a mínima de 78%.

O índice de dessaturação da oxi-hemoglobina (IDO) foi de 15,4 (nº/h), sendo que em REM foi de 42,7 (nº/h) e em NREM foi de 18,4 (nº/h). Permaneceu 5,4 % do tempo total de sono com SAO₂ abaixo de 90%.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (11), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

Considerando o registro da noite inteira observou-se:

1. Índice de distúrbio respiratório (25,9 n°/h) (VN= até 5 n°/h);
2. Saturação mínima da oxi-hemoglobina (78%);
3. Latência para o início do sono (27,5 min) (VN= 5 a 30 min);
4. Latência para o início do sono REM (105,0 min) (VN= 70 a 120 min);
5. Eficiência do sono (63,7 %) (VN= ≥ 85%);
6. Índice de despertares 20,3 n°/h (VN= até 15 n°/h);
7. Percentual do estágio N1 (1,3 %) (VN= 2% a 5%);
8. Percentual do estágio N2 (71,9 %) (VN= 45% a 55%);
9. Percentual do estágio N3 ondas delta (3,1 %) (VN= 13% a 23%);
10. Percentual do estágio REM (23,7 %) (VN= 20% a 25%);
11. Ronco verificado via sensor de ronco;

IDR (Índice de Distúrbio Respiratório) = Índice de Apnéia + Hipopnéia + RERA

Padrão de normalidade para adultos IDR: até 5/h normal, de 5 a 15/h leve, de 15 a 30/h moderado e acima de 30/h elevado.

Padrão de normalidade para crianças até 12 anos IDR: até 1/h normal, de 1 a 5/h leve, de 5 a 10/h moderado e acima de 10/h elevado.

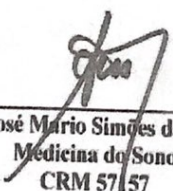
Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono de grau moderada.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57/57

Nome: JARBAS MATOS DA SILVA

Data do Exame: 03-06-2025

pág. 2